

DESBUROCRATIZACION

RESUMEN DE PROCEDIMIENTOS

Los Médicos de Atención Primaria solo están autorizados a hacer Informes de Salud o cualquier otro que pueda ser exigido legalmente, pero no deberán realizar ninguno de los siguientes documentos, ya que se escapan de su mapa competencial y de su actual cartera de servicios:

¿Qué se solicita?	¿A quién debe solicitarse?
Peritajes	Especialista en Medicina del Trabajo de su empresa
Evaluaciones de aptitud, capacidad o riesgos laborales (incluido manejo de plaguicidas)	Servicio médico de la empresa o Centro de reconocimiento habilitado
Evaluaciones de aptitud, capacidad o riesgos para actividades deportivas	Servicio médico deportivo de la federación
Evaluaciones de aptitud, capacidad o riesgos para actividades recreativas	Permiso de armas, Carnet de conducir: Centro de reconocimiento privado autorizado
Justificantes escolares	Padres o tutores legales del menor
Informes de "Fe de vida"	Juez de Paz si no está incapacitado legalmente, persona autorizada en caso de incapacitación, Poder Notarial o nombrar un Autorizado en Cuenta (bancos)
Informes para el reconocimiento de grado de discapacidad	El Equipo de Valoración y Orientación para la discapacidad (EVO) sólo admite informes de atención hospitalaria, no le sirve ninguno de primaria. Deben solicitar los informes en las secretarías de los servicios hospitalarios correspondientes

Documentos que sí deberán realizar el MF o la UAC:

¿Qué se solicita?	¿A quién debe solicitarse?
Justificantes de Asistencia con el paciente aún en consulta	Se realizará con el modelo del botón Informes de Diraya
Justificantes de Asistencia <u>después de abandonar la consulta</u> (incluido "Informes para el paro")	No hacerlo en consulta. En la UAC le sellarán el ticket de solicitud de consulta tras confirmar asistencia o le imprimirán y sellarán las propiedades de la cita (si requiere hora de inicio y fin)

Los Médicos de Atención Primaria solo están obligados a solicitar/evaluar las pruebas complementarias y/o derivaciones que estimen necesarias según su criterio clínico, pero **no están obligados a realizar ninguno de los siguientes documentos y/o procedimientos:**

¿Qué se solicita?	¿A quién debe solicitarse?
Solicitud Analítica/Prueba hospitalaria	Especialista Hospitalario
Resultados Analítica/Prueba hospitalaria	Especialista Hospitalario
Cita de Revisión/IC Hospitalaria/Perdida de cita	Especialista Hospitalario/SAC hospitalario
Derivación a Consultas Externas desde Urgencias	Servicio de Urgencias Hospital/SAC hospitalario
Volante de transporte de domicilio a hospital que no sea la primera consulta solicitada por MF	Especialista Hospitalario/SAC hospitalario
Receta hasta prox. revisión Consultas Externas	Especialista Hospitalario

Estos son los **Circuitos Administrativos** vigentes en el Centro de Salud para solicitar un Informe autorizado:

¿Qué se solicita?	Solicítelo a través de Admisión para que se lo haga:
Informe de Salud	Médico de Familia
Informe de Dependencia	Enfermero de Familia (Incluye Teleasistencia y Residencias)
Informe Sociosanitario	Trabajador Social
Renovación de Baja Laboral	Médico de Familia si así se lo indica en el último parte
Renovación de Recetas	Médico de Familia/ Enfermero de Familia

INFORMES MEDICOS

El **Informe médico** es un documento mediante el cual el médico responsable de un paciente o el que lo ha atendido en un determinado episodio asistencial, da a conocer aspectos médicos relacionados con los trastornos que el paciente sufre, los métodos diagnósticos y tratamientos aplicados y las limitaciones funcionales que se puedan derivar en el momento en que es fechado.

Su redacción debe seguir criterios estrictos de exactitud, precisión terminológica y circunspección, ya que está sujeto a reglas de responsabilidad profesional de modo que la falta de verdad puede ser causa de responsabilidad civil y/o penal, que podrían conllevar a la obligación de reparar el posible daño causado.

Puede o no ser expedido en impreso oficial de Certificados Médicos del Consejo General de Colegios Médicos de España, acreditándose en éste caso la colegiación del profesional que lo realiza. Su expedición es siempre gratuita por parte del médico, quien sólo podrá cargar los honorarios de los reconocimientos y exámenes que haya realizado si ejerce privadamente; los médicos de asistencia de centros públicos o por cuenta de terceros nunca podrán cobrar honorarios.

Se realizará siempre **a solicitud del interesado** o de la persona a que haya autorizado por escrito o de su representante legal (si está incapacitado o es menor de edad), o bien **por imperativo legal en las siguientes circunstancias**:

- A solicitud del juez (no de otros profesionales que trabajen en el caso)
- Certificado de defunción al Registro Civil
- Parte de lesiones al Juzgado de Guardia
- Informe de malos tratos al Juzgado de Guardia
- Informes de bajas laborales para Inspección Médica
- Informes de EDOs para Prevención de la Salud
- Informes para organismos externos con los que el SAS ha llegado a acuerdos:
 - Informe de Salud para la Ley de Dependencia (Diputación) que realiza Enfermería
 - Informes de Salud para Teleasistencia (Bienestar social) o ingreso en Residencia. Estos informes los puede hacer el profesional de Enfermería que es el que mejor evalúa el grado de dependencia del paciente.
- A solicitud de nuestra Dirección Médica

En estos casos suponen una obligación legal de los médicos y un derecho de los pacientes según la Ley de Salud de Andalucía 2/1998 de 15 de junio Título I, Capítulo I, Artículo 6.1, y en la vigente Carta de Derechos y Deberes de los ciudadanos en los Servicios Sanitarios Públicos de Andalucía, que dice textualmente: los ciudadanos tienen derecho “a que se les extienda certificado acreditativo de su estado de salud, cuando así lo soliciten”.

Por tanto, los Médicos de Atención Primaria **no deberán realizar ninguno de los siguientes documentos:**

- **Peritajes** (función de peritos judiciales, forenses, médicos de evaluación de incapacidades, minusvalías...)
- **Evaluaciones de aptitud, capacidad o riesgos** para puestos laborales incluyendo el manejo de plaguicidas (función del servicio médico de la empresa o centro de reconocimiento habilitado), actividades deportivas (función de los médicos deportivos de la federación) o recreativas (permiso de armas, carnet de conducir...)
- **Justificantes escolares:** Según la legislación vigente, las ausencias escolares de los menores de edad **solo pueden ser autorizadas o justificadas por sus tutores legales**, los padres, que son quienes ejercen la patria potestad y son los únicos responsables de las acciones, incluso de carácter penal, de sus hijos menores (**Código Civil. Libro I. Título VII**). La **Ley Orgánica 8/85 de 3 de julio** establece que, ante una falta de asistencia, es el profesor el que "debe notificar a los padres dicha falta y estos han de manifestar su consentimiento si lo hubiere, constituyéndose, por los derechos y obligaciones que les comporta el ejercicio de la patria potestad, en la instancia necesaria y apropiada para la acreditación de dichas ausencias al centro docente por parte de su hijo". Es una obligación de los centros escolares el seguimiento del absentismo como medida de **protección del menor**.

En nuestro país la **asistencia a centros escolares es OBLIGATORIA para los menores**, aunque haya culturas que prioricen otras actividades. En ese caso, como en el de abandono por parte de los tutores legales, si el centro sospecha que los justificantes de los tutores legales están encubriendo una falta o delito, deben hacer un informe en este sentido a Educación, quién será el que articule los mecanismos necesarios y contacte con las instituciones que precise para asegurar el bienestar y los cuidados a que el menor tiene derecho. Solicitar justificantes médicos de forma reiterada puede suponer una dejación de estas funciones y una desprotección del menor.

Por otra parte, el "justificante médico", como informe clínico, contiene datos personales que son objeto de especial protección, según determinan las normas deontológicas y legales (Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de **Protección de Datos de Carácter Personal**), no debiendo ser exigibles a las familias por parte de los centros educativos. El derecho a la intimidad es especialmente estricto en lo referente a la salud, por lo que no se deberían solicitar informes médicos ni almacenar dicha información sin unas medidas que garanticen completamente su seguridad. Incluso sin aportar demasiados datos, los justificantes pueden contener información sensible, como la especialidad médica o tipo de consulta a la que acudió el menor, que no tiene porqué ser conocida por el centro educativo.

Finalmente, la normativa vigente en materia de **derechos de los usuarios del Sistema Nacional de Salud** (*ley 41/2002, de 14 de noviembre*) no contempla la obligación del médico de realizar "justificantes escolares" a menores, salvo por petición escrita de organismos oficiales. Sólo en el caso de ingresos o convalecencias prolongadas, el profesional responsable del proceso, debería

hacer un informe para liberar al centro docente de su obligación de seguimiento en un caso que no lo precisa.

Recomendación Justificantes Escolares: no se cumplimentarán por los profesionales de este Distrito justificantes de asistencia a consultas para colegios a menores de edad.

- **Informes de "Fe de vida":** Se otorgan tras comparecencia presencial por el Encargado del Registro Civil del domicilio del paciente, o por delegación, si el interesado no puede acudir personalmente por estar impedido, por el Juez de Paz del domicilio del sujeto a que se refiere, siendo preciso en estos casos la acreditación del representante, aportando en todo caso copia de su DNI, copia del DNI del interesado, y un Informe médico reciente (con carácter general no serán admitidos Informes médicos de una antigüedad superior a quince días) u otros documentos que acrediten dicha situación. La realidad es que, aunque el Médico no otorga la "fe de vida" algunas instituciones que la requieren (bancos, sobre todo) se conforman con el Informe Médico que establezca la limitación funcional del paciente para acudir presencialmente, y cuya emisión no podemos evitar.

Recomendación informe de "Fe de Vida": informar al paciente a través de los servicios sociales del procedimiento legal de representación establecido para estas situaciones como son el Poder Notarial y la Incapacitación, y realizar en caso de entidades bancarias un Nombramiento Autorizado en Cuenta del cuidador principal

- **Justificantes de Asistencia a consulta:** Si el paciente está en la consulta se realizará con el modelo del botón Informes de Diraya. Si ya ha abandonado la consulta, no debemos hacerlo en consulta sino remitir a la UAC donde le sellarán el ticket de solicitud de consulta tras confirmar asistencia o, si requiere hora de inicio y fin de la consulta, se le imprimirá y sellará una hoja con las propiedades de la cita.

Recomendación Justificantes de Asistencia: informar al paciente de la no obligatoriedad de emitir este tipo de justificantes por parte del facultativo una vez que hayan abandonado la consulta, y de que, en todo caso, pueden utilizar si su empresa lo estima suficiente, uno de los dos documentos acreditativos asistencia a consulta sellado por los administrativos del centro tras comprobar que dicha asistencia se ha producido (Incluye "INEM o SAE")

Un caso especial de Justificante de Asistencia es el que se solicita a veces para justificar no haber comparecido en fecha ante el INEM o SAE para mantener la prestación por desempleo. Independientemente de que sea a demanda del funcionario o por iniciativa del ciudadano, la situación es la misma. No estamos obligados a hacerlos, deberá bastar con el documento de haber acudido a la consulta sellado por los administrativos del centro tras comprobar que dicha asistencia verdaderamente se produjo.

Otras recomendaciones:

Informes Sanitarios: Para facilitar la asistencia sanitaria se recomienda al usuario que necesite un informe médico de su situación de SALUD, DEPENDENCIA o situación SOCIO SANITARIA lo solicite en el mostrador de Admisión para que lo realice el profesional adecuado (Médico, Enfermero o Trabajador Social) a través del Circuito Administrativo apropiado.

Renovación Informes IT: Los informes de renovación de Bajas Laborales por IT de larga duración deben ser realizados y entregados por el MF.

RELACION INTERNIVELES

1. Pruebas complementarias solicitadas por profesionales de otro nivel asistencial:

Tanto la petición de pruebas complementarias como la confección de cualquier otra documentación que tenga que ver con profesionales hospitalarios, deberá ser realizada por éstos, ya que son los responsables de la realización de las mismas tal y como se recoge en el RD 1030/2006.

La evaluación de los resultados obtenidos en dichas pruebas también debe ser realizada por el profesional que lo solicita, ya que es el que dispone de la información para solicitarla e interpretarla.

Recomendación Pruebas Complementarias hospitalarias: No se deberán solicitar pruebas complementarias a demanda de especialistas hospitalarios, ni tampoco interpretarlas cuando no se han pedido desde AP (salvo acuerdo protocolizado).

2. Citas de revisión e interconsultas hospitalarias:

Las citas de revisión e interconsultas indicadas por los profesionales hospitalarios serán emitidas por ellos, hasta que el paciente finalice su proceso asistencial con el alta de dicho nivel. Si no se emiten o el paciente pierde la cita debe ser Cita Previa hospitalaria quien genere la nueva cita.

3. Derivaciones desde urgencias hospitalarias a consultas hospitalarias:

Si un profesional de urgencias hospitalarias estima que el paciente debe ser valorado en consulta hospitalaria, debe ser aquel quien realice la correspondiente gestión, con la finalidad de evitar duplicidades, retrasos y conflictos de competencias innecesarios. Si no se emiten o el paciente pierde la cita debe ser Cita Previa hospitalaria quien genere la nueva cita.

Las recomendaciones similares efectuadas desde los DCCU de AP deben ser gestionadas por el CS del paciente, al ser una cita generada en AP.

Recomendación de Cita de Revisión e Interconsultas hospitalarias: Los pacientes que presenten en AP solicitud de revisión, interconsulta o derivación desde urgencias hospitalaria se derivarán en sobre a Cita Previa del hospital a través del SAC, aunque hayan perdido la cita. Si no es documentable se les dará Cita telefónica/temática para que su MF evalúe la Historia Clínica y la adecuación de la revisión y/o interconsulta, derivándola al SAC si realmente procede.

4. Primeras visitas desde Atención Primaria:

Este trámite debe ser realizado por el Profesional de AP directamente o a través de Admisión de su centro, de forma que la cita se resuelva en el momento que el paciente la solicita, ofreciendo día y hora que mejor se adapte a su agenda personal, dentro de las posibilidades de la UGC. Si el paciente pierde la cita y ésta había sido diferida al no disponer de agenda el hospital, entendemos que la renovación de la cita cuando es necesaria debe ser realizada desde el Hospital. Si la cita fue gestionada desde AP (no diferida) y se produce pérdida de la misma, la gestión de la nueva cita debe ser realizada desde AP.

Recomendación de 1ª visita: Las derivaciones desde AP y las que se originen en el DCCU se deben canalizar por el MF a través de Admisión. Si el paciente pierde la cita y había sido diferida se remitirá en sobre al SAC para ser gestionadas por Cita Previa del hospital. Si no había sido diferida se solicitará nueva cita desde Admisión a cargo del facultativo que la solicitó (si el MF da su consentimiento), o se citarán como Consulta Administrativa (si el MF no consiente su gestión desde Admisión)

5. Recetas:

El profesional hospitalario debe realizar la prescripción completa, incluido visados, de los tratamientos indicados hasta la fecha de revisión. Esto no supone que el médico de familia deje de realizar la pertinente adecuación farmacológica o retire un fármaco indicado en otro nivel asistencial por motivos de intolerancia o efectos adversos al mismo.

Recomendación de Recetas: La prescripción terapéutica hasta la siguiente revisión de pacientes seguidos en consultas hospitalarias, debe realizarlas el facultativo hospitalario. Los profesionales del SAS durante su ejercicio público no pueden prescribir medicamentos avalados por informes de consultas médicas o centros asistenciales privados

Se recuerda a todos los profesionales que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) solo financia los medicamentos indicados por médicos del SAS en las recetas oficiales correspondientes. Por tanto, los Médicos que ejercen para el SAS durante su jornada laboral no pueden prescribir medicamentos avalados por informes de consultas médicas o centros asistenciales privados, de acuerdo con la legislación

vigente (Artículo 105 Decreto 2065/74 de 30 de mayo de aprobación de la Ley General de Seguridad Social). Esta normativa incluye las prescripciones de Dentistas u Odontólogos privados, de aseguradoras privadas o de especialistas privados.

6. Solicitud de transporte sanitario:

El MF realizará el documento físico o digital de ida y vuelta para las primeras consultas en Atención Hospitalaria/Consultas externas y se gestionará desde la UAC del Centro de Salud.

El FEA realizará el documento físico o digital de ida y vuelta para todas las demás consultas programadas de revisión, pruebas complementarias o reubicaciones y las gestionará el hospital.

Recomendación de Transporte: Las necesidades de transporte sanitario programado para revisiones o pruebas solicitado por ellos, desde el domicilio al hospital y vuelta debe realizarlas el facultativo hospitalario.

El Director Gerente
Distrito Córdoba y Guadalquivir

Jesús Serrano Merino